

MANUAL GUIA

PARA PESSOAS COM GASTRITE ULCERATIVA

Compreender, Tratar e Recuperar:
um guia técnico e prático de saúde digestiva, escrito em linguagem simples

Sacaíta Montgomery
Enfermeiro Generalista

Editora Karlyon Enterprise, S.A.
Beira · Sofala · Moçambique
2.^a edição revista e aumentada — 2026

© 2026 Karlyon Enterprise, S.A.

Beira, Sofala, Moçambique. Todos os direitos reservados.

Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida, copiada, distribuída, transmitida, exibida, publicada ou difundida, no todo ou em parte, por qualquer meio ou processo — electrónico, mecânico, fotocópia, gravação ou outro — sem a autorização prévia e por escrito da Editora Karlyon Enterprise, S.A. e do autor, salvo nos casos de breves citações incorporadas em artigos críticos ou académicos, devidamente identificadas, e outros usos expressamente permitidos pela legislação de direito de autor em vigor na República de Moçambique e nos demais países onde esta obra seja distribuída.

A reprodução não autorizada desta obra constitui violação dos direitos de autor e conexos, sujeitando o infractor às sanções civis e criminais previstas na lei. A pirataria editorial prejudica directamente o autor, a editora e todos os leitores que dependem de informação de saúde rigorosa e actualizada — pelo que se apela à aquisição e partilha apenas de exemplares legítimos e autorizados desta edição.

Esta obra encontra-se registada em nome da Editora Karlyon Enterprise, S.A., que detém os direitos patrimoniais de exploração, reprodução e distribuição. O nome do autor, o título, o desenho da capa e o miolo desta edição são elementos protegidos, não podendo ser utilizados, no todo ou em parte, para fins comerciais sem autorização expressa.

Marca registada: “Karlyon Enterprise” e o respectivo logótipo são propriedade da Karlyon Enterprise, S.A.

Esta obra tem carácter educativo e informativo. Não substitui, em nenhuma circunstância, a consulta, o diagnóstico ou o acompanhamento de um médico ou de outro profissional de saúde qualificado.

Ficha Técnica

Campo	Descrição
Título	Manual Guia para Pessoas com Gastrite Ulcerativa
Subtítulo	Compreender, Tratar e Recuperar: um guia técnico e prático de saúde digestiva
Autor	Sacaíta Montgomery, Enfermeiro Generalista
Editora	Karlyon Enterprise, S.A.
Local de edição	Beira, Sofala, Moçambique
Ano de publicação	2026
Edição	2. ^a edição, revista e aumentada
Género	Saúde e Bem-Estar — Manual Técnico de Apoio ao Doente
Idioma	Português (grafia anterior ao Acordo Ortográfico)
Público-alvo	Leigos, doentes e cuidadores; leitura de apoio, não substitui consulta médica
Direitos de autor	© 2026 Karlyon Enterprise, S.A. — Todos os direitos reservados

Nota: Este manual tem finalidade exclusivamente educativa e informativa. Não substitui a consulta, o diagnóstico ou o acompanhamento de um médico ou outro profissional de saúde qualificado. Qualquer alteração no tratamento, na alimentação ou na actividade física deve ser sempre discutida previamente com o médico assistente, sobretudo em caso de sinais de alarme (ver Capítulo 7).

Prefácio

Este manual nasceu da constatação, no acompanhamento diário de pessoas com problemas digestivos, de que a maior dificuldade não é seguir um tratamento — é compreendê-lo. Quando a pessoa entende o que se passa dentro do seu próprio corpo, por que motivo cada medicamento é tomado, e qual é a função de cada alimento no prato, ela deixa de ser apenas receptora de instruções e passa a participar activamente na sua recuperação.

Por isso, ao longo destas páginas, evitou-se ao máximo a frase solta e sem explicação. Sempre que possível, cada recomendação vem acompanhada do mecanismo que a sustenta: o que acontece nas células, nos tecidos e no sistema digestivo quando se segue determinado cuidado. A linguagem procura manter-se acessível a quem não tem formação em saúde, sem, no entanto, simplificar ao ponto de perder rigor técnico.

Nesta edição revista, reforçou-se de forma deliberada o carácter de manual técnico: acrescentou-se um protocolo passo-a-passo de primeiros socorros para situações de hemorragia digestiva, detalhou-se ao pormenor o modo de lavar e preparar cada um dos ingredientes do sumo de recuperação — incluindo o cuidado específico com a seiva irritante da casca da papaia — e desenvolveu-se uma secção própria e aprofundada sobre a moringa, o seu modo de uso, os cuidados de interacção medicamentosa e a forma correcta de a introduzir na rotina diária.

Este é um guia de apoio. Não substitui, em momento algum, a avaliação, o diagnóstico e o acompanhamento de um médico. O seu papel é o de tornar esse acompanhamento mais compreensível e mais participado.

Índice

1. Introdução — O que é a gastrite ulcerativa.....	5
2. Anatomia e funcionamento do estômago.....	6
3. Fisiopatologia — como a gastrite evolui para úlcera.....	8
4. Causas mais comuns.....	9
5. Sintomas e sinais de alerta.....	11
6. Diagnóstico.....	12
7. Sinais de alarme e primeiros cuidados em hemorragia digestiva.....	13
8. Fase 1 — Tratamento farmacológico de erradicação, acompanhado de suporte nutricional.....	17
9. Fase 2 — Sumo de aloe vera, papaia e banana: preparação, cuidados e moringa.....	20
10. Fase 3 — Plano alimentar diário.....	27
11. Fase 4 — Actividade física na recuperação.....	30
12. Prevenção de recidiva.....	32
13. Perguntas frequentes.....	33
14. Considerações finais.....	34
Referências e fontes de consulta recomendadas.....	35

1. Introdução — O que é a gastrite ulcerativa

A gastrite é a inflamação da mucosa que reveste o estômago — a camada interna que protege o órgão do ácido clorídrico produzido durante a digestão. Quando essa inflamação é persistente ou intensa, pode evoluir para uma úlcera: uma lesão mais profunda, que atinge camadas mais internas da parede do estômago (úlceras gástricas) ou do início do intestino delgado, o duodeno (úlceras duodenais).

De forma simples, pode imaginar-se a mucosa gástrica como uma parede protectora. Enquanto essa parede está íntegra, o ácido do estômago fica contido sem causar danos. Quando algo enfraquece essa parede — uma bactéria, um medicamento, o álcool ou o stress crónico — o ácido passa a agredir o tecido, causando dor, inflamação e, em casos mais avançados, feridas abertas (úlceras).

Convém distinguir, desde já, três graus de gravidade que este manual acompanha ao longo dos capítulos seguintes: a gastrite aguda, de instalação rápida e habitualmente reversível quando a causa é retirada; a gastrite crónica, que se mantém ao longo de meses ou anos, frequentemente ligada à presença persistente da bactéria *Helicobacter pylori*; e a úlcera péptica, estágio mais avançado, em que a perda de tecido ultrapassa a camada mais superficial da mucosa. Compreender em que ponto desta escala a própria situação se encontra ajuda a entender por que motivo o médico escolhe determinado exame ou determinado esquema terapêutico.

A boa notícia é que a gastrite e a úlcera têm tratamento eficaz na grande maioria dos casos, sobretudo quando a causa é identificada e tratada correctamente, e quando a pessoa acompanha o tratamento com uma alimentação adequada e mudanças de hábitos. Este manual segue essa lógica, capítulo a capítulo: primeiro compreender, depois tratar, depois recuperar — e, sempre que a situação o exigir, saber reconhecer o momento de procurar ajuda médica urgente.

Figura 1.1 — Espaço reservado para ilustração esquemática do estômago saudável versus estômago com gastrite/úlceras.

2. Anatomia e funcionamento do estômago

Para compreender a gastrite, é útil saber, em traços gerais, como o estômago é construído e como ele se protege a si próprio enquanto digere os alimentos.

2.1 As camadas da parede do estômago

- Mucosa — a camada mais interna, em contacto directo com o alimento e o ácido. É onde a gastrite e a úlcera se desenvolvem.
- Submucosa — camada de suporte, rica em vasos sanguíneos, que nutre a mucosa.
- Camada muscular — permite os movimentos que misturam e empurram o alimento (motilidade gástrica).
- Serosa — camada externa, que reveste o estômago por fora e o separa dos restantes órgãos abdominais.

Figura 2.1 — Espaço reservado para corte transversal das camadas da parede gástrica (mucosa, submucosa, muscular, serosa).

2.2 As células da mucosa e a sua função

Tipo de célula	Função
Células parietais	Produzem ácido clorídrico, essencial para a digestão de proteínas e para eliminar micróbios ingeridos com os alimentos.
Células principais	Produzem pepsinogénio, que o ácido converte em pepsina — a enzima que digere proteínas.
Células mucosas	Produzem muco e bicarbonato, que formam uma camada protectora sobre a mucosa, neutralizando o ácido antes que este atinja as próprias células do estômago.
Células enteroendócrinas	Libertam hormonas locais, como a gastrina, que regulam a quantidade de ácido produzido consoante a presença de alimento no estômago.

2.3 O equilíbrio entre agressão e protecção

A saúde da mucosa gástrica depende de um equilíbrio entre factores agressivos (o ácido clorídrico e a pepsina) e factores protectores (o muco, o bicarbonato e a boa circulação sanguínea local, que renova continuamente as células da superfície). Quando os factores protectores enfraquecem — por acção de uma bactéria, de um medicamento ou de hábitos como o álcool e o tabaco — o ácido deixa de ser contido e começa a lesar o próprio tecido que deveria digerir apenas o alimento. É este desequilíbrio que está na origem da gastrite e, se não for corrigido, da úlcera.

Vale ainda referir que a mucosa gástrica se renova por completo em poucos dias, através da divisão constante de células na base das suas glândulas. É precisamente esta capacidade de renovação rápida que permite, quando a causa da agressão é removida e existe suporte nutricional adequado, uma recuperação relativamente célere do tecido lesado.

3. Fisiopatologia — como a gastrite evolui para úlcera

A gastrite instala-se quando a camada protectora de muco e bicarbonato é lesada e o ácido passa a ter contacto directo com as células da mucosa. Esse contacto activa uma resposta inflamatória local: os vasos sanguíneos dilatam-se, células de defesa (glóbulos brancos) migram para a zona afectada, e são libertadas substâncias inflamatórias que causam dor, vermelhidão e edema (inchaço) do tecido — o mesmo tipo de resposta que ocorre numa ferida na pele, mas na mucosa interna do estômago.

Se a agressão persiste — por exemplo, porque a bactéria *H. pylori* continua presente, ou porque o uso de anti-inflamatórios não é interrompido — a inflamação deixa de ser superficial. As células da mucosa começam a morrer mais depressa do que conseguem ser substituídas, e a camada protectora vai-se tornando cada vez mais fina. Quando essa perda de tecido atinge camadas mais profundas da parede do estômago (ultrapassando a mucosa e atingindo a submucosa), fala-se já de uma úlcera — uma verdadeira ferida aberta, sujeita a sangrar se atingir um vaso sanguíneo, ou até a perfurar a parede do estômago em casos graves e não tratados.

Compreender esta sequência — lesão da barreira protectora, seguida de inflamação, seguida de perda progressiva de tecido, seguida de úlcera — ajuda a perceber por que motivo o tratamento tem sempre de actuar em duas frentes: eliminar a causa da agressão (Capítulo 4) e dar condições para que o tecido se regenere (Capítulos 9 e 10).

Figura 3.1 — Espaço reservado para esquema da sequência: lesão da barreira → inflamação → perda de tecido → úlcera.

4. Causas mais comuns

4.1 Infecção por *Helicobacter pylori* (H. pylori)

É a causa mais comum de gastrite crónica e úlcera péptica em todo o mundo. Esta bactéria consegue sobreviver ao ambiente ácido do estômago porque produz uma enzima chamada urease, que neutraliza o ácido à sua volta, criando uma zona protegida onde se instala, junto à camada de muco. A partir daí, liberta substâncias que enfraquecem directamente essa camada protectora e provocam uma resposta inflamatória contínua na mucosa. Transmite-se principalmente por via oral-oral ou fecal-oral, associada a água ou alimentos contaminados.

4.2 Uso prolongado de anti-inflamatórios não esteróides (AINEs)

Medicamentos como o ibuprofeno, o diclofenac e o ácido acetilsalicílico actuam bloqueando uma enzima (a ciclo-oxigenase, ou COX) que, entre outras funções, é responsável pela produção de prostaglandinas — substâncias que, no estômago, estimulam a produção de muco e bicarbonato protectores. Ao bloquear essa enzima, estes medicamentos aliviam a dor noutras partes do corpo, mas, como efeito colateral, reduzem também a protecção natural da mucosa gástrica, deixando-a mais vulnerável ao próprio ácido do estômago.

4.3 Consumo excessivo de álcool

O álcool tem acção irritante directa sobre as células da mucosa, podendo danificar a camada de muco protector e, em consumo elevado ou frequente, lesar directamente as células epiteliais.

4.4 Tabagismo

O tabaco reduz o fluxo de sangue para a mucosa gástrica (por acção vasoconstritora da nicotina), o que diminui a capacidade de renovação e reparação das células. Também reduz a produção de bicarbonato protector, retardando a cicatrização e aumentando o risco de recidiva.

4.5 Stress crónico e má alimentação

O stress crónico não causa gastrite por si só, mas mantém o sistema nervoso e hormonal em estado de alerta constante, o que pode alterar a produção de ácido e reduzir o fluxo sanguíneo para o aparelho digestivo. Combinado com uma alimentação irregular ou pobre em nutrientes, este estado agrava os sintomas e dificulta a recuperação da mucosa já lesada.

5. Sintomas e sinais de alerta

Os sintomas mais comuns da gastrite e da úlcera incluem dor ou ardor na região superior do abdômen (muitas vezes descrita como “queimadura” no estômago), sensação de estufamento, náuseas, enjoo, azia, arrotos frequentes e perda de apetite. A dor pode piorar ou melhorar com a alimentação, dependendo da localização da lesão: nas úlceras gástricas, a dor tende a agravar-se pouco depois de comer; nas úlceras duodenais, é frequente aliviar temporariamente com a alimentação e regressar horas depois, inclusive durante a noite.

Existem, porém, sinais de alarme que exigem avaliação médica imediata, detalhados no Capítulo 7, incluindo o protocolo de primeiros cuidados perante uma hemorragia digestiva. Nunca ignore esses sinais à espera de que “passem sozinhos”.

6. Diagnóstico

O diagnóstico da gastrite/úlceras e da infecção por *H. pylori* é feito pelo médico, habitualmente através de um ou mais dos seguintes métodos:

Método	Como funciona
Endoscopia digestiva alta com biópsia	Permite observar directamente a mucosa e recolher uma pequena amostra de tecido para confirmar a presença de inflamação, úlcera ou da bactéria <i>H. pylori</i> .
Teste respiratório da ureia	A pessoa ingere uma substância que, na presença da urease produzida pela <i>H. pylori</i> , liberta um composto detectável no ar expirado.
Pesquisa de antígeno nas fezes	Detecta proteínas da bactéria <i>H. pylori</i> numa amostra de fezes.
Análise de sangue	Detecta anticorpos contra a <i>H. pylori</i> ; hoje é menos utilizada para confirmar infecção activa, porque os anticorpos podem persistir mesmo depois de a bactéria ter sido eliminada.

É este diagnóstico que vai orientar se o tratamento com antibióticos é necessário.

7. Sinais de alarme e primeiros cuidados em hemorragia digestiva

7.1 Sinais de alarme

Embora a maioria dos casos de gastrite e úlcera evolua bem com tratamento adequado, existem sinais que exigem avaliação médica imediata, pois podem indicar complicações como hemorragia digestiva ou perfuração. Procure um serviço de urgência se surgir qualquer um dos seguintes sinais:

- Vômito com sangue (vermelho vivo ou com aspecto de borra de café).
- Fezes muito escuras, semelhantes a alcatrão (melena), ou com sangue vermelho vivo.
- Dor abdominal súbita, muito intensa, tipo “facada”, sobretudo se acompanhada de abdómen rígido.
- Tonturas intensas, desmaio, palidez acentuada ou sensação de fraqueza súbita.
- Perda de peso não intencional e rápida.
- Dificuldade persistente em engolir.
- Vômitos repetidos que não param.
- Febre associada a dor abdominal intensa.
- Pulso acelerado, respiração rápida ou suor frio, mesmo sem dor intensa.

Nota: Nestes casos, não espere para “ver se passa”: procure imediatamente um serviço de urgência ou contacte o seu médico assistente.

7.2 Primeiros cuidados em caso de hemorragia digestiva — estabilização antes de chegar à urgência

A hemorragia digestiva alta é uma das complicações mais sérias da úlcera péptica e constitui sempre uma emergência médica. O que se descreve nesta secção não é tratamento — é um conjunto de medidas simples de estabilização, que qualquer pessoa pode aplicar enquanto se aguarda o transporte para um serviço de urgência ou a chegada de ajuda especializada. Nenhuma destas medidas substitui a avaliação hospitalar, que deve ser sempre procurada de imediato.

Passo 1 — Reconhecer e não desvalorizar

Vômito com sangue vivo ou em “borra de café”, fezes negras e pegajosas (melena), palidez súbita, tonturas, suor frio ou desmaio são sinais de perda de sangue activa. Perante qualquer um destes sinais, accione de imediato o número de emergência local ou dirija-se ao serviço de urgência mais próximo — não aguarde para confirmar se “é mesmo sangue” ou se “vai passar”.

Passo 2 — Posicionar a pessoa correctamente

- Se a pessoa está consciente e não vomita: deitar de costas, com as pernas ligeiramente elevadas (usando uma almofada ou objecto sob os pés), para favorecer o retorno de sangue ao coração e ao cérebro.
- Se a pessoa está a vomitar, sonolenta ou com risco de perder a consciência: colocar em posição lateral de segurança (deitada de lado, com a cabeça ligeiramente inclinada para baixo e para o lado), de modo a evitar que o vômito ou o sangue sejam engolidos para as vias respiratórias (aspiração).
- Manter a pessoa quieta e o mais calma possível — a agitação aumenta a frequência cardíaca e pode agravar a perda de sangue.

Passo 3 — O que NÃO fazer

- Não dar nada para comer ou beber, incluindo água, chá ou leite — o estômago deve ficar vazio, tanto para reduzir o risco de vômito como para permitir uma eventual endoscopia de urgência.
- Não administrar qualquer medicamento por conta própria, em especial anti-inflamatórios ou ácido acetilsalicílico, que podem agravar a hemorragia.
- Não tentar provocar o vômito.
- Não deixar a pessoa sozinha em nenhum momento.

Passo 4 — Vigiar e manter a pessoa estável

- Manter a pessoa aquecida (com um cobertor ou manta leve), pois a perda de sangue pode causar sensação de frio e queda de temperatura corporal.
- Vigiar o nível de consciência: falar com a pessoa, chamá-la pelo nome, confirmar se responde de forma coerente.
- Vigiar a respiração: confirmar que respira de forma regular e sem grande dificuldade.
- Se a pessoa perder a consciência mas continuar a respirar normalmente, mantê-la em posição lateral de segurança e não a deixar deitada de costas.
- Se a pessoa deixar de respirar ou não houver pulso, iniciar de imediato manobras de reanimação, caso a pessoa presente tenha formação para tal, e nunca interromper os contactos para pedir ajuda urgente.

Passo 5 — Preparar a transferência para o hospital

- Contactar de imediato os serviços de emergência ou organizar transporte urgente para o hospital mais próximo com serviço de urgência.
- Reunir, se possível, a lista de medicamentos que a pessoa toma habitualmente (incluindo anti-inflamatórios, anticoagulantes ou aspirina), para informar a equipa médica.
- Anotar, se conseguir, a hora aproximada em que os sintomas começaram e a quantidade estimada de sangue observada (por exemplo, número de episódios de vômito ou de dejeções).
- Levar consigo, se existir, a medicação habitual e documentos de identificação ou de saúde da pessoa.

Atenção: Uma hemorragia digestiva pode agravar-se rapidamente e sem aviso. Mesmo que os sinais pareçam ligeiros ou que a pessoa diga sentir-se melhor, a avaliação hospitalar é sempre necessária, porque só o médico, com recurso a exames, pode confirmar se a hemorragia parou e se existe necessidade de intervenção (como endoscopia com hemostase ou, em casos raros, cirurgia).

8. Fase 1 — Tratamento farmacológico de erradicação, acompanhado de suporte nutricional

Este é o primeiro passo do plano e só se aplica quando a infecção por *Helicobacter pylori* é confirmada por exame médico (Capítulo 6). Se o exame não confirmar a infecção, esta fase não se aplica e o tratamento segue outro plano, definido pelo médico consoante a causa identificada.

8.1 Esquema geral

Classe do medicamento	Função no tratamento
Inibidor da bomba de prótons (IBP) — ex.: omeprazol, pantoprazol, esomeprazol	Reduz a produção de ácido no estômago, protege a mucosa lesada e cria um ambiente que aumenta a eficácia dos antibióticos.
Antibióticos (esquema combinado, definido pelo médico)	Eliminam a bactéria <i>H. pylori</i> na mucosa gástrica.

Nota: As doses, a combinação exacta dos antibióticos e a duração do tratamento são sempre definidas pelo médico assistente, de acordo com o histórico da pessoa e a resistência bacteriana local. Este manual não substitui essa prescrição.

8.2 Cuidados durante esta fase

- Tomar a medicação exactamente como prescrita, respeitando horários e a duração total, mesmo que os sintomas melhorem antes do fim.
- Nunca interromper o tratamento por conta própria — a interrupção precoce é uma das principais causas de falha na erradicação e de resistência bacteriana.
- Evitar álcool, tabaco e anti-inflamatórios não esteróides (AINEs) durante todo o tratamento.
- Nesta fase, a actividade física limita-se a caminhada leve e alongamentos (ver Capítulo 11).
- O sumo de aloe vera, papaia e banana (Capítulo 9) só deve começar depois de concluído o tratamento medicamentoso.

8.3 Suporte nutricional que acompanha o tratamento medicamentoso

Embora o sumo de aloe vera, papaia e banana só deva ser introduzido após a conclusão dos antibióticos, isso não significa que a alimentação deva ser deixada ao acaso durante esta primeira fase. Pelo contrário: um suporte nutricional simples, ligeiro e bem escolhido acompanha todo o tratamento farmacológico, ajudando a reduzir o desconforto e a preparar o terreno para a fase seguinte.

- Preferir refeições pequenas e frequentes (5 a 6 vezes ao dia) em vez de duas ou três refeições volumosas, reduzindo a distensão gástrica e o desconforto pós-prandial.
- Optar por alimentos de fácil digestão: sopas de legumes bem cozidos, papas simples (milho, aveia ou trigo), arroz bem cozido, batata cozida, banana madura, peito de frango ou peixe cozido.
- Evitar, já nesta fase, frituras, condimentos muito picantes, café em excesso, refrigerantes, bebidas gaseificadas, álcool e alimentos muito ácidos — os mesmos hábitos a evitar detalhados no ponto 10.3.

- Manter uma boa hidratação com água e infusões suaves, evitando bebidas muito quentes ou muito frias, que podem aumentar o desconforto gástrico.
- Mastigar devagar e com calma, num ambiente tranquilo, o que reduz a quantidade de ar engolido e favorece uma digestão mais eficiente.

Nota: Esta alimentação de suporte é diferente do sumo de aloe vera, papaia e banana descrito no Capítulo 9: serve para acompanhar e tornar mais confortável a fase de erradicação medicamentosa, enquanto o sumo é introduzido apenas depois, já na fase de recuperação nutricional mais intensiva.

8.4 Confirmação da erradicação

Depois de terminado o esquema de antibióticos, o médico deve confirmar se a bactéria foi eliminada, através de um novo teste — geralmente feito, no mínimo, quatro semanas após o fim dos antibióticos e com suspensão prévia do IBP, conforme orientação médica. É só depois desta confirmação que a Fase 2 (recuperação nutricional) deve ganhar todo o seu peso no plano.

9. Fase 2 — Sumo de aloe vera, papaia e banana: preparação, cuidados e moringa

9.1 Este sumo é sempre indicado?

Não. É uma opção de apoio nutricional complementar, não uma etapa obrigatória do tratamento. Pode ser considerada por pessoas em recuperação, sem outras condições que a contra-indiquem, e idealmente com o aval do médico ou nutricionista. Não substitui, em nenhuma circunstância, o tratamento farmacológico descrito no Capítulo 8.

Quando NÃO é indicado

- Durante o tratamento com antibióticos — a prioridade é a erradicação da bactéria.
- Em grávidas e crianças pequenas, sem orientação médica específica.
- Em pessoas com doença renal ou intestinal conhecida (a aloe vera pode ter efeito laxativo e sobrecarregar estas condições).
- Em caso de alergia conhecida a plantas da família das Liliáceas/Aloáceas.
- Se, em qualquer momento, causar diarreia, cólicas ou desconforto — suspender de imediato e informar o médico.

9.2 Como lavar e preparar cada ingrediente, passo a passo

A preparação cuidadosa de cada ingrediente não é um pormenor menor: é parte essencial da segurança deste sumo, sobretudo no caso da aloe vera e da papaia, que contêm substâncias irritantes que devem ser completamente removidas antes do consumo.

A) Aloe vera — como limpar em segurança

- Cortar a folha junto à base da planta, com uma faca limpa, e deixá-la em repouso na vertical, com o corte virado para baixo, durante 10 a 15 minutos, num recipiente. Este passo permite escorrer a aloína — o látex amarelo, amargo e irritante, situado logo abaixo da casca — que de outro modo contaminaria o gel.
- Lavar bem a folha em água corrente, esfregando a casca para remover qualquer resíduo do látex amarelo escorrido.
- Cortar as pontas espinhosas das margens da folha e, com uma faca, retirar toda a casca verde exterior, expondo apenas o gel transparente do interior.
- Retirar cuidadosamente qualquer resquício da camada amarelada situada mesmo por baixo da casca — é nesta camada fina que se concentra a aloína.
- Lavar novamente o gel transparente em água corrente antes de o cortar em cubos e o colocar no liquidificador.

Atenção: Nunca utilizar a casca ou a camada amarelada da aloe vera no sumo. A aloína é um forte irritante e laxante intestinal, podendo causar diarreia, cólicas intensas e desidratação, especialmente prejudicial numa pessoa já com a mucosa digestiva sensível.

B) Papaia — cuidado com a seiva (látex) da casca

A papaia, sobretudo quando ainda não está completamente madura ou quando é colhida directamente da árvore, liberta uma seiva leitosa e esbranquiçada, rica numa enzima chamada papaína em estado bruto e

concentrado. Esta seiva, ao contrário da polpa madura já pronta para consumo, pode ser irritante para a pele, para as mucosas e para o próprio estômago sensível, podendo causar ardor, coceira na pele de quem manuseia a fruta, e desconforto digestivo se ingerida em quantidade.

- Escolher sempre papaia bem madura, de casca amarelada e polpa alaranjada, na qual a concentração de seiva bruta é já muito reduzida.
- Ao cortar a fruta, se surgir um líquido leitoso esbranquiçado na zona do corte ou do caule, lavar a faca e as mãos de imediato, e deixar a fruta escorrer esse líquido antes de continuar a descascar.
- Descascar por completo, removendo toda a casca exterior, e retirar sempre as sementes pretas do centro, que não devem ser utilizadas no sumo.
- Lavar bem a polpa já descascada em água corrente antes de a cortar em pedaços para o liquidificador.
- Evitar por completo a papaia verde (não madura) neste sumo — é nela que a concentração de seiva e de papaína bruta é mais elevada, e o seu uso está associado a maior risco de irritação da mucosa digestiva já fragilizada.

Atenção: Pessoas com sensibilidade cutânea conhecida ao látex devem manusear a papaia com luvas, pois existe alguma reactividade cruzada descrita entre o látex da borracha e certas proteínas do látex da papaia.

C) Banana — preparação simples

- Escolher banana bem madura (casca com pintas escuras), mais fácil de digerir e menos adstringente do que a banana verde.
- Lavar a casca antes de a descascar, para evitar transferir sujidade da casca para a polpa durante o manuseamento.
- Retirar por completo os filamentos fibrosos que ficam colados à polpa, se forem grossos.

D) Preparação final do sumo

- Juntar o gel de aloe vera já limpo, a papaia madura descascada e sem sementes, e a banana madura, no copo do liquidificador.
- Adicionar água potável, fervida e arrefecida ou filtrada, em quantidade suficiente para obter uma bebida homogénea, nem demasiado espessa nem demasiado líquida.
- Bater até obter uma mistura lisa, sem pedaços.
- Preparar e consumir de preferência no mesmo dia, guardando eventual sobra no frigorífico por, no máximo, algumas horas, num recipiente limpo e tapado.

Figura 9.1 — Espaço reservado para fotografia/ilustração dos ingredientes do sumo (aloe vera, papaia e banana) e do processo de limpeza da folha de aloe vera.

9.3 Modo de tomar — passo a passo

- Sempre em jejum, com o estômago vazio — nunca depois de uma refeição.
- 1.º momento: logo ao acordar, antes de escovar os dentes, ainda em jejum.
- 2.º momento: ao meio-dia, também em jejum (estômago vazio, isto é, cerca de 3 a 4 horas sem ter comido).
- 3.º momento: ao final da tarde, novamente em jejum.

- Começar sempre por uma porção pequena (meio copo) para avaliar a tolerância individual antes de aumentar a quantidade.
- Depois de tomar o sumo, esperar cerca de 15 a 20 minutos e beber um pequeno copo de água morna, aos golinhos, devagar.
- Cerca de 1 hora depois do sumo (ou 45 a 60 minutos depois da água morna), fazer uma refeição leve — por exemplo, sopa de legumes com uma fatia de pão integral.
- A meio da manhã e a meio da tarde, entre as refeições principais, pode incluir-se um sumo de fruta natural mais denso (ex.: papaia, manga) ou papas simples, mantendo a alimentação leve e fraccionada ao longo do dia.
- Suspender de imediato caso surja diarreia, cólicas fortes ou qualquer desconforto, e informar o médico.

9.4 Componentes e benefícios — sistema imunológico, celular e digestivo

Esta secção explica, componente a componente, por que motivo cada ingrediente é utilizado — não apenas o quê, mas o mecanismo biológico por trás de cada acção.

Aloe vera

Componente	Acção no organismo
Acemanano (polissacárido)	É uma molécula bioactiva que interage com receptores de células do sistema imunitário, nomeadamente macrófagos. Estudos de laboratório sugerem que pode estimular a actividade destas células de defesa e influenciar processos ligados à reparação de tecidos e à cicatrização.
Polissacáridos gerais	Formam uma estrutura viscosa (tipo gel) que reveste temporariamente a superfície das mucosas. Esta camada pode ajudar a manter um ambiente mais protegido para as células epiteliais que revestem o tubo digestivo, reduzindo o contacto directo com irritantes.
Compostos fenólicos (antioxidantes)	Neutralizam radicais livres — moléculas instáveis produzidas em excesso durante processos inflamatórios, que danificam a membrana e o material genético das células. Ao reduzir esse excesso, os antioxidantes diminuem a lesão celular associada à inflamação.
Minerais (zinco, magnésio, entre outros)	Funcionam como cofactores — isto é, participam activamente em reacções enzimáticas necessárias ao metabolismo celular e à síntese de proteínas envolvidas na reparação de tecidos.

Papaia

Componente	Acção no organismo
Papaína (enzima proteolítica, na polpa madura)	Ajuda a quebrar as proteínas dos alimentos em fragmentos menores (aminoácidos e péptidos), facilitando a digestão e reduzindo a carga de trabalho do estômago numa fase em que a mucosa está sensível.
Vitamina C	Participa directamente na síntese de colagénio, a proteína estrutural que forma a matriz de suporte dos tecidos — incluindo a mucosa gástrica em reparação. Também apoia a função dos leucócitos e actua como

	antioxidante.
Betacaroteno (precursor da vitamina A)	É convertido no organismo em vitamina A, que participa na manutenção e renovação das células epiteliais que revestem por dentro o estômago e o intestino.
Fibras	Servem de substrato para as bactérias benéficas do intestino, que as fermentam produzindo ácidos gordos de cadeia curta, como o butirato — importantes para a saúde e energia das células intestinais.

Banana

Componente	Ação no organismo
Fibras solúveis (pectina)	Alimentam a microbiota intestinal benéfica, favorecendo a produção de ácidos gordos de cadeia curta que nutrem directamente as células que revestem o intestino.
Potássio	Participa no equilíbrio dos líquidos dentro e fora das células e é essencial para o funcionamento normal dos músculos — incluindo os músculos do próprio tubo digestivo.
Vitamina B6	Actua como cofactor em várias reacções do metabolismo energético celular.
Magnésio	Participa como cofactor em centenas de reacções enzimáticas, incluindo as envolvidas na contracção muscular e na síntese de proteínas.

9.5 Moringa — modo de uso detalhado, cuidados e interacção medicamentosa

A moringa (*Moringa oleifera*) é uma planta amplamente utilizada em Moçambique e em toda a região, valorizada pela sua riqueza em vitaminas, minerais e compostos antioxidantes. Pode ser incluída como complemento à dieta de recuperação, mas — precisamente por ser rica em compostos bioactivos — merece um capítulo próprio de cuidados, sobretudo no que respeita à sua introdução junto de medicamentos.

Como se apresenta e como se prepara

- Folhas frescas: lavar abundantemente em água corrente, de preferência com algumas gotas de solução de higienização de vegetais, e deixar secar à sombra antes de as usar em sopas ou infusões.
- Folhas secas em pó (a forma mais comum e mais fácil de dosear): conservar em recipiente fechado, ao abrigo da luz e da humidade, para preservar as vitaminas sensíveis ao calor e à oxidação.
- Infusão: dissolver uma pequena quantidade de pó de moringa (cerca de uma colher de café rasa) em água morna, não fervente, deixando repousar alguns minutos antes de beber — a água muito quente pode destruir parte da vitamina C presente.

Quando e como tomar

- Tomar em pequenas quantidades, de forma fraccionada ao longo do dia — habitualmente duas a três vezes por dia — em vez de uma dose única e concentrada, o que reduz o risco de desconforto digestivo e melhora a tolerância.
- Tomar antes das refeições principais, cerca de 15 a 20 minutos antes de comer, o que permite avaliar a tolerância digestiva antes de introduzir outros alimentos.

- Começar sempre por uma quantidade pequena (por exemplo, meia colher de café de pó, ou uma infusão suave) e aumentar apenas de forma gradual, ao longo de vários dias, observando como o corpo reage.
- Evitar tomar a moringa exactamente ao mesmo tempo que os comprimidos, mantendo um intervalo de pelo menos 30 a 60 minutos entre a moringa e a toma de qualquer medicamento — esta precaução simples reduz a probabilidade teórica de a moringa interferir com a absorção de certos fármacos.

Interacção medicamentosa — o que é preciso verificar antes

A moringa não deve ser vista como “inofensiva só porque é natural”. Alguns dos seus compostos têm efeitos discretos, mas reais, sobre a tensão arterial, o açúcar no sangue e a coagulação, pelo que a sua introdução junto de tratamento medicamentoso deve ser sempre conversada com o médico, sobretudo nas seguintes situações:

- Pessoas a tomar medicação para a tensão arterial (anti-hipertensores) — a moringa pode ter um ligeiro efeito adicional de redução da tensão.
- Pessoas a tomar medicação para a diabetes (antidiabéticos orais ou insulina) — a moringa pode ter um ligeiro efeito adicional de redução do açúcar no sangue, o que exige vigilância para evitar hipoglicemia.
- Pessoas a tomar anticoagulantes ou antiagregantes plaquetários — pela prudência geral que qualquer suplemento vegetal exige nestes casos.
- Grávidas — a moringa em quantidades concentradas não é recomendada durante a gravidez, sem orientação médica específica.

Nota: Se, depois de confirmado junto do médico que não existe contra-indicação nem interacção relevante com os medicamentos que a pessoa toma, a moringa pode ser incluída em pequenas quantidades, duas a três vezes ao dia, de preferência antes das refeições, mantendo sempre o intervalo de segurança em relação à toma dos comprimidos. Perante qualquer dúvida sobre um medicamento específico, a pergunta correcta a fazer ao médico ou farmacêutico é sempre: “posso tomar moringa juntamente com este medicamento, e com que intervalo?”

Atenção: Suspender o uso da moringa e informar o médico se surgir tontura incomum, quedas de tensão, sudção fria ou sintomas de açúcar baixo no sangue (tremores, fome súbita, confusão), sobretudo em pessoas já medicadas para a tensão arterial ou para a diabetes.

10. Fase 3 — Plano alimentar diário

Estrutura diária pensada para a fase de recuperação: refeições pequenas, leves, fraccionadas e de fácil digestão, organizadas em torno do sumo de aloe vera, papaia e banana.

Momento	O que fazer
Ao acordar (jejum)	Sumo de aloe vera + papaia + banana, em pequena quantidade — antes de escovar os dentes.
15–20 min depois	Pequeno copo de água morna, bebida devagar, aos golinhos.
~1h depois do sumo	Refeição leve: sopa de legumes (batata, cenoura, abóbora, espinafre, ervilhas, quiabo) com pão integral, ou papas simples (milho, aveia ou trigo) com banana.
Meio da manhã	Sumo de fruta natural denso (papaia, manga) ou uma fruta madura.
Meio-dia (jejum)	Sumo de aloe vera + papaia + banana.
15–20 min depois	Água morna, aos golinhos.
~1h depois	Almoço leve: sopa de legumes com pequena porção de massa; proteína leve (frango, peixe ou ovo cozido).
Meio da tarde	Fruta madura (manga, pera sem casca/sementes) ou sumo natural.
Final da tarde (jejum)	Sumo de aloe vera + papaia + banana.
15–20 min depois	Água morna, aos golinhos.
~1h depois / jantar	Refeição leve semelhante ao almoço, evitando frituras, condimentos fortes, álcool e bebidas gaseificadas.

10.1 Componentes nutricionais do plano — visão geral

Componente	Fonte principal	Acção no organismo	Benefício esperado
Proteínas	Frango, peixe, ovo	Fornecem aminoácidos, as unidades básicas usadas para construir novas proteínas estruturais.	Reparação dos tecidos lesados da mucosa
Vitamina A	Cenoura, espinafre, papaia	Participa na regulação da renovação das células epiteliais.	Manutenção e integridade da mucosa
Vitamina C	Papaia, outras frutas	Cofactor essencial na produção de colagénio.	Cicatrização
Zinco	Carnes, sementes	Participa em enzimas envolvidas na síntese de proteínas e na função imunitária.	Defesa imunitária e reparação celular
Ferro	Carnes, moringa, fígado ocasional	Componente da hemoglobina, que transporta oxigénio até aos tecidos em reparação.	Oxigenação dos tecidos

Fibras	Legumes e frutas	Alimentam a microbiota intestinal, que produz ácidos gordos de cadeia curta.	Saúde da mucosa intestinal e melhor trânsito
--------	------------------	--	--

10.2 Outras frutas recomendadas nesta fase

Fruta	Porquê é recomendada
Banana madura	Boa tolerância digestiva, pouco ácida
Papaia	Rica em fibras e enzimas digestivas
Melão	Hidratante, rico em vitaminas, pouco ácido
Manga madura	Rica em antioxidantes
Pera madura (sem casca nem sementes)	Rica em fibras suaves para o intestino
Maçã (se bem tolerada)	Pode ser consumida se não causar desconforto

Bebidas a preferir: água e sumos naturais suaves. Bebidas a evitar: álcool, refrigerantes e bebidas muito ácidas ou gaseificadas.

10.3 Alimentos e hábitos a evitar durante a recuperação

- Frituras e alimentos muito gordurosos.
- Condimentos muito picantes.
- Café em excesso e bebidas com muita cafeína.
- Refrigerantes e bebidas gaseificadas.
- Bebidas alcoólicas.
- Alimentos muito ácidos (citrinos em excesso, vinagre concentrado).
- Fumar.
- Refeições muito volumosas de uma só vez — preferir porções menores e mais frequentes.

11. Fase 4 — Actividade física na recuperação

A actividade física leve tem um papel de apoio na recuperação, ajudando a circulação, o metabolismo e o bem-estar geral. A intensidade, porém, deve respeitar a fase do tratamento.

11.1 Durante o tratamento medicamentoso

Nesta fase, priorize apenas caminhada leve (20 a 30 minutos, em ritmo confortável) e alongamentos suaves, sem forçar a região abdominal. Evite exercícios intensos, musculação pesada ou qualquer actividade que aumente muito a pressão abdominal enquanto os sintomas estiverem activos ou o tratamento estiver em curso.

11.2 Após conclusão e confirmação da erradicação

Caminhada

Durante a caminhada, os músculos aumentam a sua necessidade de oxigénio, levando o coração a bombear sangue com maior eficiência. Esta melhoria da circulação favorece a entrega de oxigénio e nutrientes aos tecidos, incluindo o sistema digestivo, acelerando a reparação da mucosa. O exercício regular também influencia hormonas metabólicas, reduz a inflamação sistémica associada ao excesso de gordura corporal e melhora a sensibilidade das células à insulina. Manter 30 minutos diários, num ritmo moderado, ajuda a circulação e o controlo da glicemia.

Respiração diafragmática

Ao respirar profundamente com o abdómen (em vez de respirar superficialmente com o peito), o diafragma desce e sobe com maior amplitude, o que gera um suave efeito de massagem sobre os órgãos abdominais e melhora o retorno venoso. Este tipo de respiração também activa o sistema nervoso parassimpático — o ramo do sistema nervoso associado ao repouso e à digestão — o que pode favorecer o relaxamento e o conforto digestivo, e reduzir o estado de alerta que agrava os sintomas em pessoas com stress crónico.

Mobilidade abdominal suave

Rotações leves do tronco e alongamentos mobilizam suavemente a musculatura e o tecido conjuntivo à volta do abdómen, sem gerar dor. Isto melhora a mobilidade geral, reduz a tensão muscular acumulada e favorece indirectamente a circulação local, sempre sem forçar a região.

A introdução de exercícios mais intensos deve ser progressiva e, idealmente, acompanhada por um profissional de saúde, sobretudo se ainda existir desconforto digestivo.

Figura 11.1 — Espaço reservado para ilustração de caminhada leve, alongamento e respiração diafragmática.

12. Prevenção de recidiva

Tratar a gastrite ou a úlcera uma vez não garante que não voltem. A prevenção de recidiva assenta em manter afastados os factores que, no Capítulo 4, foram identificados como agressores da mucosa:

- Evitar o uso não supervisionado e prolongado de anti-inflamatórios não esteróides — quando forem necessários, perguntar ao médico sobre protecção gástrica associada.
- Moderar ou evitar o consumo de álcool.
- Não fumar — o tabaco atrasa a cicatrização e reduz a protecção natural da mucosa, como explicado no Capítulo 4.
- Manter uma alimentação equilibrada e regular, evitando longos períodos em jejum seguidos de refeições muito volumosas.
- Gerir o stress crónico, através de sono adequado, actividade física regular e, se necessário, apoio psicológico — o stress não causa a doença sozinho, mas mantém o corpo num estado que dificulta a reparação da mucosa.
- Se surgirem novamente sintomas digestivos persistentes, procurar avaliação médica cedo, em vez de esperar que “passem sozinhos”.

13. Perguntas frequentes

Posso tomar o sumo de aloe vera mesmo antes de terminar o tratamento com antibióticos?

Não é recomendado. A prioridade nesta fase é a erradicação da bactéria com o esquema prescrito. O sumo pode ser introduzido após a conclusão do tratamento medicamentoso.

O sumo de aloe vera substitui os medicamentos?

Não. Trata-se de um apoio nutricional complementar, sem evidência de que cure ou substitua o tratamento médico da infecção.

Posso fazer exercício intenso enquanto tenho sintomas?

Não é aconselhável. Prefira caminhada leve e alongamentos até que os sintomas melhorem e o tratamento esteja concluído.

Quanto tempo demora a recuperação total?

Varia de pessoa para pessoa, dependendo da gravidade inicial, da adesão ao tratamento e dos hábitos de vida. O acompanhamento médico regular é a melhor forma de avaliar a evolução.

Posso voltar a ter gastrite ou úlcera depois de tratada?

Sim, sobretudo se persistirem factores de risco como uso frequente de anti-inflamatórios, tabagismo, álcool ou nova infecção por *H. pylori*. Por isso, manter hábitos saudáveis a longo prazo é importante (ver Capítulo 12).

A papaia verde pode ser usada no sumo, se for isso que houver em casa?

Não. A papaia deve estar bem madura antes de entrar no sumo. A papaia verde contém uma concentração muito mais elevada de seiva e de papaína bruta, que pode irritar uma mucosa digestiva já sensível (ver ponto 9.2-B).

Posso tomar moringa ao mesmo tempo que os meus comprimidos habituais?

Só depois de confirmar com o médico que não há interacção relevante com os seus medicamentos específicos. Ainda assim, como regra geral de segurança, mantenha sempre um intervalo de 30 a 60 minutos entre a toma da moringa e a toma de qualquer comprimido (ver ponto 9.5).

14. Considerações finais

A recuperação da gastrite e da úlcera associada ao *H. pylori* assenta em três pilares que se complementam: primeiro, a eliminação da causa, através do tratamento farmacológico prescrito pelo médico; depois, o apoio de uma alimentação rica em nutrientes e de fácil digestão; e, por fim, a retoma gradual da actividade física, sempre respeitando os limites do corpo em cada fase da recuperação.

A estes três pilares, esta edição acrescenta um quarto elemento, igualmente essencial: saber reconhecer os sinais de alarme e agir correctamente nos primeiros minutos de uma eventual hemorragia digestiva, enquanto se aguarda ajuda médica especializada. Esse conhecimento, simples mas decisivo, pode fazer a diferença entre uma situação controlada e uma complicação grave.

Nenhum alimento, sumo ou hábito, por mais benéfico que seja, substitui o diagnóstico e o acompanhamento médico. Este manual pretende ser um guia técnico de apoio, escrito em linguagem acessível, para ajudar a pessoa leiga a compreender melhor a sua condição e a participar activamente na sua própria recuperação — sempre em diálogo com os profissionais de saúde que a acompanham.

Referências e fontes de consulta recomendadas

Este manual foi escrito com base em princípios gerais de fisiologia digestiva e de nutrição amplamente aceites na literatura de saúde. Para aprofundamento e confirmação clínica, recomenda-se a consulta das seguintes fontes:

- Organização Mundial da Saúde (OMS/WHO) — orientações sobre *Helicobacter pylori* e doença péptica.
- Ministério da Saúde de Moçambique — orientações clínicas nacionais.
- Sociedades científicas de gastroenterologia — directrizes de diagnóstico e tratamento da gastrite e úlcera péptica.
- Manuais de referência de fisiologia humana e de farmacologia clínica, para os mecanismos descritos nos Capítulos 2, 3, 4 e 11.
- Bases de dados científicas (ex.: PubMed) — para estudos sobre composição nutricional e potenciais efeitos bioactivos de aloe vera, papaia, banana e moringa, referidos no Capítulo 9.

Nota: *Este manual não cita estudos específicos individuais porque tem finalidade educativa geral; para decisões clínicas concretas, consulte sempre o seu médico, que tem acesso à evidência mais actual e ao seu historial de saúde.*

© 2026 Karlyon Enterprise, S.A. — Beira, Sofala, Moçambique. Todos os direitos reservados.
Esta obra tem carácter educativo e não substitui aconselhamento médico profissional.